

NUTRISOFT

Documento Maestro

Estilo, producto, requisitos y continuidad

Fuente de verdad para continuar, migrar, rediseñar o auditar NutriSoft sin perder decisiones importantes.

Versión 1.1 • 14 de agosto de 2026

Cierre funcional 2.2 verificado + backend seguro multi-tenant 2.1 verificado localmente

Este documento debe leerse antes de realizar cambios de producto, UI, datos, permisos o arquitectura. No sustituye los contratos técnicos específicos; los referencia y explica en contexto.

1. Cómo usar y mantener este documento

1.1 Jerarquía de autoridad

Si dos fuentes parecen contradecirse, resolver en este orden:

1. Seguridad, privacidad, RLS e invariantes de base de datos.
2. Contrato de API y modelo de datos vigente.
3. Código implementado y pruebas automatizadas.
4. Este documento maestro y decisiones funcionales aprobadas.
5. Backlog, prototipos, mocks y referencias competitivas.

1.2 Estados de una función

Estado	Significado	Regla de comunicación
Implementado	Existe y funciona en el frontend o backend actual.	Puede describirse como disponible en el entorno correspondiente.
Simulado	Funciona con MockProvider y datos ficticios, sin persistencia o integración real.	Mostrar “Modo demostración — datos ficticios”.
Planificado	Alcance definido, todavía no implementado.	Mostrar “Próximamente” sólo cuando sea útil para anticipar navegación.
Futuro	Idea aprobada conceptualmente pero requiere discovery, arquitectura o validación.	No prometer fecha ni disponibilidad.

1.3 Protocolo de actualización

- Toda decisión que cambie navegación, permisos, tokens, estados, datos o un flujo central debe actualizar este archivo.
- Registrar la decisión en la sección “Historial de decisiones”.

- No documentar como definitivo un precio, límite comercial o integración todavía ficticia.
- Conservar el motivo de las decisiones sensibles; no limitarse a describir la pantalla.
- Al migrar, comparar la implementación nueva contra los criterios de aceptación de este documento.

2. Visión del producto

NutriSoft es una plataforma SaaS clínica y operativa para nutricionistas, consultorios y pacientes en Latinoamérica. Debe reducir carga administrativa, ordenar el seguimiento y elevar la calidad percibida sin deshumanizar la atención ni automatizar decisiones clínicas de forma opaca.

2.1 Promesa central

- Para el consultorio: administración clara de profesionales, pacientes, planes, pagos, vencimientos y permisos.
- Para el nutricionista: una práctica ordenada por prioridad, con menos trabajo repetitivo y contexto clínico accesible.
- Para el paciente: una experiencia móvil simple, cercana y comprensible para responder, consultar y sentirse acompañado.
- Para NutriSoft: una operación comercial agregada que nunca expone información clínica identificable al Platform Admin.

2.2 Principios no negociables

1. Privacidad por diseño.
2. Aislamiento multi-tenant estricto.
3. El criterio profesional prevalece sobre cualquier automatización.
4. La interfaz explica estados y próximos pasos; no obliga a adivinar.
5. Los cambios importantes deben ser auditables y, cuando sea posible, reversibles.
6. Se prioriza claridad y estabilidad sobre acumulación de funciones.
7. El sistema nunca presenta una inferencia como diagnóstico.

2.3 Fuera de alcance del Platform Admin

El Platform Admin administra cuentas, consultorios, planes, pagos, vencimientos, estados y métricas agregadas. No accede a historia clínica, check-ins, alertas clínicas, recomendaciones, notas, fotos, mediciones ni contenido identificable del paciente.

3. Roles y permisos

3.1 Roles de negocio

Rol	Responsabilidad	Acceso esperado
Platform Admin	Opera la plataforma y relación comercial B2B.	Consultorios, planes, pagos, estados, uso y métricas agregadas. Cero datos clínicos.
Responsable/Owner	Administra su consultorio. Puede haber más de uno.	Equipo, pacientes del consultorio, facturación propia y administración según políticas del tenant.
Nutricionista	Atiende pacientes asignados.	Sólo pacientes asignados, sus check-ins, alertas, recomendaciones, recursos y recetas propias.
Assistant	Apoya la operación administrativa.	Directorio básico reducido; sin contenido clínico.
Paciente	Usa su portal personal.	Su ficha, asignaciones, respuestas y recomendaciones propias.

3.2 Reglas de aislamiento

- Todo dato clínico debe estar vinculado a `organization_id` y, cuando corresponda, a `patient_id` y profesional asignado.
- Un nutricionista no ve pacientes, recursos ni recetas de otro profesional, aunque pertenezcan al mismo consultorio, salvo que exista una función explícita de biblioteca compartida y permiso aprobado.
- Un paciente no ve información de otro paciente ni puede usar un identificador ajeno para abrir un check-in.
- El Assistant recibe un directorio reducido sin fecha de nacimiento, ciudad, objetivo nutricional ni información clínica.
- Una organización suspendida pierde acceso operacional clínico hasta su reactivación conforme a política.

- Las acciones administrativas y clínicas sensibles deben dejar auditoría sin contenido clínico innecesario.

4. Estado técnico y arquitectura

4.1 Fases

- Fase 1 — Prototipo visual: cerrada y estabilizada como `v0.1.0-prototype`.
- Fase 2.1 — Backend foundation seguro y multi-tenant: verificado localmente con Supabase.
- Fase 2.2 — Cierre funcional del prototipo: alertas con ciclo completo, recomendaciones trazables y publicación controlada de recursos/recetas, verificados en modo mock.
- Frontend actual: modo mock funcional mediante `MockProvider`; todavía no conectado directamente a Supabase.
- Siguiendo fase recomendada: Fase 3, autenticación e integración segura de datos reales, preservando contratos, privacidad y RLS.

4.2 Stack vigente

- React 19, React DOM 19 y TypeScript 5.7.
- Vite 6 y Tailwind CSS 4.
- React Router DOM 6.30 con `createHashRouter`.
- Radix UI para Dialog, Switch y Toast; Lucide React para iconografía.
- React Hook Form + Zod para formularios.
- Vitest + Testing Library + jest-dom para frontend.
- Supabase/PostgreSQL con pgTAP para backend.
- Node requerido: `>=24 <25`.

4.3 Esquemas de backend

- `app`: persistencia interna. Fuera del Data API; sin DML directo para `authenticated`.
- `security`: funciones auxiliares basadas en `auth.uid()`, con `SECURITY DEFINER` y `search_path` cerrado.
- `api`: única superficie pública, mediante vistas `security_invoker` y RPC transaccionales.

4.4 Invariantes críticas

- `check_in_responses` y `audit_logs` son inmutables: no se actualizan ni eliminan.
- Las recomendaciones deben referenciar una respuesta del mismo tenant y paciente.
- Las asignaciones sólo pueden apuntar a miembros activos con rol `nutritionist` u `owner`.
- No se puede degradar o desactivar un miembro con asignaciones clínicas activas.
- Toda escritura real debe pasar por RPC autorizada; el frontend no escribe directamente en tablas internas.
- Las transiciones de alertas y cobros deben ser idempotentes y verificables.

4.5 Comandos de verificación

```
npm run dev
npm run verify:frontend
npm run verify:database
npm run verify:all
```

5. Arquitectura de navegación

5.1 Rutas actuales

Portal	Ruta	Estado	Función
General	/	Implementado	Redirige a <code>/professional</code> .
Admin	<code>/admin</code>	Simulado	Resumen comercial y operativo agregado.
Admin	<code>/admin/organizations</code>	Simulado	Lista y gestión de consultorios.
Admin	<code>/admin/organizations/:organizationId</code>	Simulado	Perfil del consultorio.

Admin	/admin/nutritionists	Simulado	Lista de nutricionistas.
Admin	/admin/nutritionists/:nutritionistId	Simulado	Perfil del nutricionista en tarjetas.
Admin	/admin/nutritionists/:nutritionistId/patients/:patientId	Simulado	Acceso contextual y limitado desde el profesional.
Profesional	/professional	Simulado	Inicio del nutricionista.
Profesional	/professional/inbox	Simulado	Bandeja de atención.
Profesional	/professional/patients	Simulado	Pacientes asignados.
Profesional	/professional/patients/:patientId	Simulado	Perfil operativo del paciente.
Profesional	/professional/resources	Simulado	Recursos propios.
Profesional	/professional/recipes	Simulado	Recetario propio.
Paciente	/patient	Simulado	Inicio mobile-first.
Paciente	/patient/check-in/:assignmentId	Simulado	Formulario de check-in aislado.
Desarrollo	/design-system	Implementado sólo DEV	Catálogo visual. Debe devolver 404 en producción.

5.2 Navegación planificada

- Profesional: Agenda/Citas como primera opción; Check-ins, Recomendaciones, Reportes y Configuración.
- Admin: Facturación y Configuración.
- Paciente: Recomendaciones y Más.
- Las opciones futuras se muestran deshabilitadas con badge “Próximamente”; no deben parecer clicables.

5.3 Regla de acceso contextual del Admin

No existe una ruta general de pacientes para el Platform Admin. El acceso administrativo a una ficha reducida se realiza exclusivamente desde el perfil del nutricionista responsable. La ruta </admin/patients> debe responder con una explicación de acceso no permitido.

6. Dirección visual

6.1 Personalidad

- SaaS profesional, tecnológico, humano, minimalista y refinado.
- Referencias de calidad: Linear, Notion, Stripe y Apple Health.
- El producto debe sentirse sereno y preciso, no infantil ni hospitalario.
- Evitar verde médico oscuro, frutas, balanzas, cintas métricas y clichés de dietética.
- Evitar colores saturados, sombras fuertes, bordes gruesos y decoraciones sin función.

6.2 Paleta oficial

Token	Valor	Uso
--bg-app	#F7F9FA	Fondo general.
--surface	#FFFFFF	Tarjetas, modales y paneles.
--surface-subtle	#F2F7F8	Inputs, filtros y fondos secundarios.
--surface-tinted	#EDF8F7	Contenedores suaves de marca.
--text-primary	#1A1A1A	Títulos, datos y texto principal.
--text-secondary	#667788	Explicaciones y etiquetas.
--text-tertiary	#8A959D	Metadatos y estados pasivos.
--border-subtle	#E2E9EC	Bordes estándar.
--border-hover	#CCD9DE	Hover y separación reforzada.
--brand-primary	#55AEB8	Marca e interacción positiva.
--brand-strong	#337388	Texto/ícono de marca y foco.
--brand-soft	#DDF3F2	Fondos suaves de marca.
--aqua-soft	#BDE9EA	Acento suave.
--sky-soft	#CFE8F5	Acento informativo visual.
--mint-soft	#D8F0E8	Apoyo positivo.
--butter-soft	#F5E8A9	Acento cálido y graduaciones.

6.3 Colores semánticos

Estado	Texto	Fondo	Regla
Información	#5267C7	#EAEFFC	Explicar, no alarmar.
Advertencia	#C98A27	#FDF6E2	Requiere atención, no peligro inmediato.
Crítico	#C95F59	#FCEBEA	Acción prioritaria o destructiva.
Éxito	#39835A	#E8F5EE	Confirmación o estado estable.

Nunca comunicar un estado sólo mediante color. Combinar color con etiqueta, ícono o descripción.

6.4 Gradientes permitidos

- Acción principal: `linear-gradient(90deg, #AEE5E8 0%, #CDEAF5 52%, #F5E6A4 100%)`.
- Tarjeta destacada: `linear-gradient(135deg, #E9F8F7 0%, #EEF7FB 58%, #FCF9E8 100%)`.
- CTA paciente: `linear-gradient(90deg, #B9EAEC 0%, #D5EDF6 50%, #F4E5A1 100%)`.
- Navegación activa: `linear-gradient(90deg, #D9F3F2 0%, #E3F1F8 100%)`.
- Ícono de marca: `linear-gradient(135deg, #8EDADD 0%, #A9DFF3 55%, #EDE196 100%)`.

Los gradientes usan texto oscuro #151B22; no deben convertirse en fondos decorativos dominantes.

7. Tipografía, espacio y forma

7.1 Tipografía

Familia: `Inter, ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, sans-serif`.

Rol	Tamaño / línea	Peso recomendado
H1 de página	28/34 px	700
H2 de sección	22/28 px	600–700
H3/tarjeta	18/24 px	600–700
Cuerpo	14/20 px	400–500
Texto pequeño	12/16 px	500–600
Microtexto	10–11 px	500–700; sólo metadatos o badges.

No reducir texto funcional para “hacerlo entrar”. Priorizar ancho, wrapping, scroll horizontal controlado o simplificación.

7.2 Espaciado

- Unidad base: 4 px.
- Separaciones frecuentes: 8, 12, 16, 20, 24, 32 px.
- Padding de página: 16 px móvil, 24 px tablet y 32 px desktop.
- Máximos de contenido actuales: 1180–1440 px en Admin; `max-w-md` en Paciente.
- Formularios: separación vertical mínima de 12–16 px; acciones separadas por borde o espacio claro.

7.3 Radios y elevación

- Controles compactos: 8–12 px.
- Botones e inputs estándar: 12 px (`rounded-xl`).
- Tarjetas: 16 px (`rounded-2xl`).
- Hero o contenedor principal: 24 px (`rounded-3xl`).
- Pill/badge: radio completo.
- Sombras: muy suaves; preferir borde antes que elevación. Modal y menú flotante pueden usar sombra media.

7.4 Movimiento

- Duración estándar: 150–200 ms.
- Animar color, opacidad, sombra o transformación pequeña.
- No usar animaciones que demoren acciones clínicas ni movimiento ornamental continuo.
- Respetar `prefers-reduced-motion` cuando se incorporen animaciones complejas.

8. Diseño responsive por rol

8.1 Admin

- Desktop-first.

- Sidebar fija de 256 px desde `md`; ocultarla en móvil hasta definir navegación alternativa.
- Tablas pueden usar `overflow-x-auto` y ancho mínimo explícito.
- Priorizar datos agregados, filtros, estados y acciones de gestión.

8.2 Profesional

- Desktop-first con adaptación tablet.
- Sidebar textual; contador de alertas sin resolver.
- Dashboard y bandeja orientados a acción, no a decoración.
- Fichas de detalle en tarjetas y secciones; evitar navegación por pestañas excesivamente fragmentada.

8.3 Paciente

- Mobile-first, ancho de lectura limitado.
- Navegación inferior fija con objetivos principales.
- Targets táctiles mínimos de 44 × 44 px.
- Lenguaje cotidiano, frases cortas y una acción principal por pantalla.

9. Componentes y patrones

9.1 Botones

Variantes vigentes:

- `primary`: gradiente de marca; acción principal de la pantalla o modal.
- `brand`: aqua sólido; acción de marca secundaria.
- `secondary`: superficie suave con borde.
- `outline`: acción secundaria transparente.
- `ghost`: navegación o acción de baja jerarquía.
- `destructive`: fondo crítico suave; cerrar, suspender o acción irreversible.

Reglas:

- Máximo una acción visualmente primaria por bloque.

- Tamaños: sm 36 px, md 44 px, lg 48 px de altura mínima.
- Toda acción sólo con ícono necesita `aria-label` y tooltip cuando su significado no sea universal.
- Deshabilitado debe comunicar también la razón mediante texto cercano cuando la acción sea importante.

9.2 Tarjetas

- Superficie blanca, borde sutil, radio 16 px, sombra mínima.
- `highlighted` usa gradiente suave aprobado.
- Una tarjeta debe agrupar una unidad coherente: métrica, estado, persona, recurso o acción.
- No usar tarjetas como contenedor de cada línea; evitar fragmentación visual.

9.3 Badges y estados

- Badges generales: `high`, `medium`, `normal`, `active`, `suspended`, `pending`, `info`, `neutral`.
- Estados de consultorio mediante badge-trigger interactivo:
- Activo: verde.
- Pago pendiente: amarillo.
- Suspendido: naranja.
- Cerrado: rojo.
- El badge actual actúa como disparador de menú compacto en español.
- Mostrar opción actual y actualizar etiqueta/color inmediatamente después de confirmar.

9.4 Inputs

- Label visible sobre el control.
- Fondo `surface-subtle`, borde `border-subtle`, radio 12 px.
- Focus con `brand-strong` y superficie blanca.
- Error mediante texto específico y asociación `aria-describedby`; nunca sólo borde rojo.
- Campos obligatorios identificados de forma consistente.

9.5 Dialog/Modal

- Radix Dialog con overlay oscuro suave, backdrop blur, trampa y restauración de foco, cierre con Escape.
- Ancho máximo estándar `max-w-lg`; alto máximo 85 vh con scroll interno.
- Encabezado con título, descripción y cerrar accesible.
- Acciones: cancelar a la izquierda de confirmar; acción destructiva claramente diferenciada.
- Al cerrar exitosamente, limpiar formulario y devolver foco al disparador.

9.6 Toast

- Tipos: éxito, error e información.
- Ícono, título y descripción opcional.
- Se muestra abajo a la derecha en desktop; debe adaptarse sin salirse del viewport móvil.
- No usar toast como único lugar para información necesaria para corregir un formulario.

9.7 Tablas

- Encabezados legibles y `scope="col"`.
- Datos alineados por tipo; números y acciones mantienen consistencia.
- Filas con separación sutil; no cuadrícula pesada.
- Mobile/tablet: contenedor con scroll horizontal y ancho mínimo explícito.
- Acciones principales deben seguir disponibles por teclado.
- Estado vacío visible debajo del encabezado o como bloque reemplazo.

9.8 Menús flotantes de badge

- Trigger con `aria-haspopup="menu"`, `aria-expanded` y label contextual.
- Menú absoluto con ancho cercano a 12 rem, superficie blanca, borde y sombra.
- Elementos con rol `menuitem`; indicar opción actual con texto, no sólo color.
- Cerrar al seleccionar, Escape o click exterior cuando se incorpore implementación completa.

9.9 Escalas 1-5

- Usar `fieldset`, `legend` e inputs radio reales.
- Cada opción tiene 44 × 44 px como mínimo.
- Selección visible mediante fondo, contraste y cambio de forma/elevación.
- El error se asocia al grupo completo.

9.10 Estado vacío, carga y error

Cada módulo debe definir:

- Cargando: skeleton o texto que conserve jerarquía.
- Vacío inicial: qué es el módulo y acción para crear el primer elemento.
- Vacío por filtro: “No encontramos...” y opción de limpiar filtros.
- Error recuperable: causa comprensible y reintentar.
- Sin permiso: explicar límite sin revelar existencia de datos.
- Requiere plan/verificación: condición, beneficio y próximo paso.
- Próximamente: deshabilitado, no fingir una función disponible.

10. Lenguaje y contenido

10.1 Voz

- Profesional, clara, cálida y directa.
- Español rioplatense coherente en portales internos: “Gestioná”, “Confirmá”, “Ingresá”.
- En Paciente puede usarse español neutral o cercano, pero no mezclar tratamientos dentro de una misma experiencia.
- Evitar jerga técnica, culpabilización, diagnósticos automáticos y promesas clínicas.

10.2 Convenciones

- “Consultorio” en UI; “organization” sólo en código/arquitectura.
- “Nutricionista” o “profesional” según contexto; no usar términos ingleses visibles.
- Estados: Activo, Pago pendiente, Suspendido, Cerrado.

- Fechas visibles en formato local `es-AR`; fechas de sistema en ISO.
- Importes en ARS con `Intl.NumberFormat`, sin centavos salvo necesidad real.
- “Última actividad” incluye fecha, hora y valor relativo.

10.3 Microcopy clínica

- El check-in confirma recepción de datos, no interpreta ni diagnostica.
- Una alerta explica hecho, importancia y acción sugerida.
- Una recomendación pertenece a un profesional identificable.
- La IA debe declararse como asistencia y nunca hablar con autoridad clínica autónoma.

11. Accesibilidad

- Objetivo mínimo: WCAG 2.1 AA.
- Foco global visible: anillo de 2 px sobre superficie + 2 px `brand-strong`.
- Targets táctiles de 44 px en móvil y controles importantes.
- HTML semántico: landmarks, títulos jerárquicos, listas, tablas, labels y botones reales.
- No usar `div` clicable sin rol/teclado.
- Contraste suficiente en texto, badges y botones.
- Iconos decorativos no duplican texto para lectores de pantalla.
- Modales gestionan foco y Escape.
- Errores se anuncian y enlazan al campo.
- Estados no dependen sólo del color.
- Controles y navegación deben funcionar con teclado.

12. Requisitos del portal Admin

12.1 Resumen general

Estado actual: simulado.

- Encabezado “Super Admin · Vista comercial”.

- Métricas: consultorios activos, nutricionistas y pacientes activos agregados.
- Botón + **Nuevo consultorio** visible.
- Mensaje permanente de privacidad por diseño.
- Las métricas jamás deben contener información clínica identificable.

12.2 Atención comercial

Tarjetas:

1. Vencen en 3 días.
2. Pendiente de pago.
3. Próximo a suspensión.
4. Suspendidos.

Reglas:

- Listar nombres de consultorios cuando el conteo es mayor que cero.
- Cuando el conteo es cero, no mostrar separador, etiquetas ni nombres vacíos.
- Permitir “Registrar pago” directamente donde corresponda.
- No incluir botón redundante “Ver consultorios”; la navegación principal ya resuelve ese acceso.

12.3 Gráfico de evolución de plataforma

Estado actual: simulado y estilizado.

- Estética limpia, sobria y minimalista.
- Sin ejes Y ni unidades visibles en laterales.
- Conservar sólo meses en eje X.
- Series: Consultorios activos, Pacientes activos y Cobros reales.
- Filtros de tiempo obligatorios: Mes actual, 3 meses, 6 meses, Todo y Personalizado.
- Los filtros de serie actúan como toggles accesibles y deben mostrar una diferencia inequívoca entre activo/inactivo.
- Tooltip por mes con valores exactos.
- Si hay varias series activas, tooltip con desglose; si hay una, mostrar sólo esa serie.
- El filtro personalizado define inicio y fin válidos y comunica el rango aplicado.

12.4 Lista de consultorios

Estado actual: simulado.

- Búsqueda y filtros de estado/plan.
- Tabla con consultorio, estado, plan/tarifa, nutricionistas, pacientes, vencimiento, facturación, almacenamiento y detalle.
- + **Nuevo consultorio** también en la cabecera de esta sección.
- Estado mediante badge-dropdown en español, no select tradicional.
- Plan/tarifa mediante badge-dropdown editable on-the-fly.
- Al cambiar plan, actualizar precio y almacenamiento asociados sin recarga.
- Registrar pago disponible por fila.
- Mantener scroll horizontal controlado en viewports estrechos.

12.5 Alta de consultorio

Estado actual: simulado; envío real de email pendiente de backend.

Campos obligatorios:

- Nombre del consultorio.
- Ubicación.
- Plan inicial.
- Nombre completo del responsable.
- Email del responsable.

Resultado esperado:

- Crear consultorio con plan y ubicación.
- Crear responsable principal vinculado.
- Dejar invitación en estado pendiente.
- En backend real, enviar email transaccional para configurar acceso.
- Redirigir al perfil del consultorio y mostrar confirmación.

12.6 Perfil del consultorio

Estado actual: simulado en formato de tarjetas.

- Hero con nombre, ubicación, plan, estado e invitación pendiente.
- Tarjetas resumen: tarifa, vencimiento, profesionales y pacientes.
- Responsables: principal y adicionales, con estado de invitación.
- Acción + [Agregar responsable adicional](#) disponible para Platform Admin y responsable principal/actual.
- Profesionales: listado e invitaciones pendientes.
- Acción + [Agregar profesionales al consultorio](#).
- Facturación/pagos: registrar pago e historial.
- Almacenamiento: usado, límite y porcentaje; Custom puede ser flexible.

12.7 Invitaciones

Responsable adicional:

- Campos: Nombre y apellido, correo electrónico.
- Al confirmar: crear invitación pendiente; backend real envía email.
- Al aceptar: mismo rol de Responsable del Consultorio, sujeto a matriz de permisos.
- Evitar email duplicado dentro del consultorio.

Profesional:

- Campos: Nombre completo, correo electrónico.
- Al confirmar: invitación pendiente y email real en backend.
- Al aceptar: completa datos básicos y queda vinculado al consultorio.
- No asignar pacientes automáticamente sin una acción explícita.

12.8 Pagos y vencimientos

Estado actual: registro manual simulado.

Modal [Registrar pago](#):

- Consultorio y plan precargados.
- Monto del plan precargado, editable sólo si la política lo permite.
- Fecha de pago por defecto hoy, editable.
- Próximo vencimiento calculado desde el vencimiento actual sumando un mes y preservando el día cuando exista.

- Método y nota/comprobante opcional.
- Al confirmar: estado Activo, limpiar suspensión, avanzar vencimiento, crear historial y retirar alertas comerciales derivadas.
- Reactivar desde Suspendido o Cerrado requiere pago confirmado.
- En backend real, operación transaccional e idempotente.

12.9 Lista y perfil de nutricionistas

Estado actual: simulado.

- Lista con nutricionista, organización, pacientes asignados, fecha de alta, última actividad, estado y acción.
- Última actividad muestra día, horario y valor relativo.
- Perfil individual en tarjetas, no en una navegación de “fichas” incómoda.
- Aplicar el formato a todos los nutricionistas, no sólo al ejemplo.
- Mostrar resumen, organizaciones, pacientes asignados, actividad operativa y estado de cuenta mediante bloques claros.

13. Requisitos del portal Nutricionista

13.1 Inicio

Estado actual: simulado.

- Saludo y contexto del profesional/consultorio seleccionado.
- Resumen de pacientes y alertas relevantes.
- Acceso directo a Bandeja de atención y pacientes.
- Evitar métricas sin acción asociada.

13.2 Agenda / Citas

Estado: planificado fase 2; visible deshabilitado como primera opción.

- Día, semana y mes.
- Próximas citas, disponibilidad y estados.

- En fases posteriores: tipos de consulta, sedes, profesionales, reservas públicas, recordatorios y sincronización externa.
- La agenda debe seguir funcionando si falla una integración de calendario externa.

13.3 Bandeja de atención

Estado actual: simulada con reglas determinísticas y ciclo funcional cerrado en Fase 2.2.

Debe responder:

1. ¿Qué paciente necesita atención?
2. ¿Qué ocurrió?
3. ¿Por qué importa?
4. ¿Qué acción debería realizar el nutricionista?

Reglas actuales:

- Pedido explícito de ayuda: prioridad alta.
- Energía $\leq 2/5$: prioridad alta.
- Adherencia $\leq 2/5$: prioridad alta.
- Código `DELAYED_CHECKIN` reservado para desarrollo posterior.

Estados: sin resolver, reconocida y resuelta. Reconocer conserva autor y fecha sin retirar la alerta de los pendientes; resolver conserva autor y fecha y finaliza el caso. No se permiten transiciones duplicadas ni descartes silenciosos.

13.4 Pacientes

Estado actual: simulado.

- Mostrar únicamente pacientes asignados al nutricionista activo y del mismo consultorio.
- Búsqueda y alta rápida con validación.
- Columnas/información relevante: contacto, objetivo, plan actual, última actividad y acceso al portal.
- Perfil con resumen, check-ins y recomendaciones.
- Acciones: asignar check-in, emitir recomendación y consultar historial.

13.5 Check-ins

Estado actual: flujo simulado; módulo general planificado.

- El profesional asigna un check-in a un paciente propio.
- El paciente responde energía 1-5, adherencia 1-5, pedido de ayuda y notas opcionales de hasta 500 caracteres.
- La respuesta se registra una sola vez.
- Las reglas generan alertas sin producir diagnóstico.
- Respuestas reales serán inmutables en base de datos.

13.6 Recomendaciones

Estado actual: emisión desde perfil; módulo general planificado.

- Texto obligatorio, creado por profesional autorizado.
- En el flujo 2.2 se vincula automáticamente con la respuesta de check-in más reciente del paciente cuando existe; si no existe, queda identificada como recomendación general.
- Visible sólo para paciente y equipo clínico autorizado.
- Conservar fecha, autor y vínculo de origen.

13.7 Recursos / Biblioteca

Estado actual: cierre funcional simulado en Fase 2.2.

- Botón principal para agregar recurso.
- Tipos iniciales: documento y enlace/video.
- Campos: título, categoría y archivo o URL.
- Todo recurso pertenece a `organization_id` y `ownerNutritionistId`.
- Estados editoriales: borrador, publicado y retirado.
- Sólo el autor puede cambiar el estado de publicación en el prototipo actual.
- Se comparte automáticamente y exclusivamente con pacientes propios/asignados cuando está publicado.
- Retirar un recurso elimina inmediatamente su visibilidad del portal Paciente; devolverlo a borrador lo mantiene privado.
- No visible para pacientes de otro profesional, incluso en el mismo consultorio.

- Aislamiento total entre consultorios.
- Fases posteriores: archivos en storage privado, versiones, miniaturas, analítica y biblioteca compartida del consultorio con aprobación explícita.

13.8 Recetario

Estado actual: cierre funcional simulado en Fase 2.2 con ejemplos; formateo IA futuro.

- Vista en grilla de tarjetas.
- Foto principal, categoría, tags de dieta, tiempo, porciones, calorías y macros.
- Buscador y filtros por nombre, categoría y etiquetas.
- Categorías iniciales: Desayunos, Almuerzos, Cenas y Snacks.
- Alta con título, ingredientes, preparación, porciones y datos nutricionales.
- Estados editoriales: borrador, publicado y retirado; sólo las publicadas están disponibles para pacientes propios.
- Duplicar siempre crea un borrador propio, conserva la procedencia y no modifica el original.
- Nunca modificar una receta ajena al copiar; una biblioteca compartida requerirá permisos y contratos adicionales.
- Ejemplos demostrativos: 4-5 recetas variadas para que la vista sea útil desde el inicio.

IA futura para recetas:

- Recibe borrador del profesional.
- Propone título, ingredientes estructurados, pasos, porciones, etiquetas y formato visual.
- No inventa cantidades ni macros sin marcar incertidumbre.
- Entrega borrador editable; publicación exige aprobación humana.

13.9 Reportes

Estado: futuro recomendado.

- Seleccionar paciente, período y plantilla.
- Activar, desactivar, editar y ordenar secciones.
- Preview y PDF coherentes.
- Secciones posibles: identidad, resumen, peso, medidas, antropometría, macros, adherencia, bienestar, plan, consultas, notas, recomendaciones y firma.

- Guardar snapshot de datos, versión, autor y registro de entrega.

14. Requisitos del portal Paciente

14.1 Inicio

Estado actual: simulado y mobile-first.

- Saludo con primer nombre.
- Estado del check-in: pendiente, vencido o al día.
- Una acción principal para responder cuando esté pendiente.
- Recomendaciones del profesional.
- Recursos y recetas publicados por el nutricionista asignado, con estados vacíos comprensibles.
- Consultorio, nutricionista asignado y estado de acceso al portal.

14.2 Check-in

- Validar que la asignación exista y pertenezca al paciente autenticado.
- Si es ajena o inválida, responder sin revelar datos.
- Si está vencida, explicar y volver al portal.
- Si ya fue completada, impedir segunda respuesta.
- Confirmación neutral: "recibido/registrado"; no sugerir diagnóstico ni interpretación.
- Accesibilidad completa de escalas, switch, errores y submit.

14.3 Contenido sincronizado

- Estado actual: simulado y validado en Fase 2.2.
- Recursos y recetas publicados por su nutricionista asignado y pertenecientes al mismo consultorio.
- Borradores y contenido retirado nunca se muestran al paciente.
- El cambio de estado se refleja sin recargar la página dentro de la sesión mock.
- Plan y recomendaciones vigentes.
- La reasignación de profesional debe recalcular acceso sin filtrar contenido anterior indebido.

- Antes de datos reales, definir explícitamente qué contenido histórico permanece visible después de una reasignación.

15. IA embebida: política y requisitos

15.1 Principio

La IA se inserta dentro de una tarea concreta; no se usa un chat genérico como arquitectura principal.

15.2 Niveles de autonomía

Nivel	Comportamiento	Uso aceptable
0	Consulta y explicación.	Ayuda contextual, sin cambios.
1	Genera borrador.	Recetas, resúmenes, reportes y mensajes.
2	Propone una acción.	Sugiere plan, etiqueta o seguimiento.
3	Ejecuta sólo con confirmación.	Crear entidad o enviar contenido revisado.
4	Automatización reversible preautorizada.	Recordatorios de bajo riesgo con reglas claras.

15.3 Prohibiciones

- No diagnosticar ni prescribir autónomamente.
- No publicar o enviar contenido clínico sin aprobación profesional.
- No mezclar datos entre tenants.
- No entrenar modelos con datos clínicos por defecto.
- No ocultar fuentes, incertidumbre o autoría asistida.
- No ejecutar acciones irreversibles en modo autónomo.

15.4 Auditoría de IA

Conservar propósito, modelo/versión, fuentes utilizadas, salida, campos inciertos, costo, aprobador y versión final. Toda salida debe poder descartarse y existir una alternativa manual.

16. Reglas comerciales y datos mock actuales

Los siguientes valores sirven para la demostración y no constituyen una política comercial definitiva:

Plan	Precio mock mensual	Almacenamiento mock
Basic	ARS 30.000	1 GB
Pro	ARS 60.000	5 GB
Ultra	ARS 100.000	15 GB
Custom	ARS 200.000	Flexible

Antes de producción, definir moneda, impuestos, actualización, límites, prorrateo, período, reembolsos y tratamiento de cambios de plan.

17. Formularios y validación

- Preferir React Hook Form + Zod.
- Normalizar email a minúsculas y trim.
- Validar campos obligatorios antes de mutar estado.
- Mostrar mensajes específicos y recuperables.
- No cerrar un modal ante error.
- Deshabilitar doble submit y diseñar idempotencia para backend real.
- Fechas de entrada locales; persistencia en ISO con zona horaria definida.
- Archivos: tipo, tamaño, antivirus, URL firmada y política de retención.

18. Testing y definición de terminado

18.1 Frontend

- Lint sin errores.
- Typecheck sin errores.
- Tests Vitest/Testing Library en verde.
- Build de producción exitoso.
- Flujos por rol y aislamiento cubiertos.

- Estados vacío, error, sin permiso y éxito verificados.
- Prueba por teclado de formularios y modales.

18.2 Backend

- Reset de base reproducible.
- pgTAP en verde.
- Lint de esquemas `api`, `app`, `security` sin errores.
- Tipos generados alineados con migraciones.
- Pruebas negativas cross-tenant y de privilegio mínimo.
- RPC transaccional, idempotente cuando corresponda y con auditoría.

18.3 UI

- Comparar contra `/design-system` en desarrollo.
- No introducir hex aislados si existe token adecuado.
- Validar desktop y mobile según rol.
- Verificar contraste, foco, targets, labels, overflow y textos largos.
- No romper flujos existentes al realizar ajustes estéticos.

19. Convenciones de implementación

- Componentes UI reutilizables en `src/components/ui`.
- Componentes de dominio en `src/components/domain`.
- Layouts y rutas agrupados por rol en `src/app`.
- Tipos compartidos en `src/types`.
- Funciones puras de negocio en `src/lib`.
- Mocks y motor de reglas en `src/mocks`.
- Tokens globales en `src/styles/globals.css`.
- Evitar lógica clínica/comercial duplicada dentro de páginas.
- Contadores derivados no deben guardarse como fuente paralela de verdad.
- Usar IDs y firmas públicas que no permitan al cliente elegir arbitrariamente otro usuario o tenant.

20. Checklist de migración

20.1 Código y entorno

- Copiar repositorio completo, historial Git y tags.
- Usar Node 24 y lockfile vigente.
- Verificar variables de entorno sin copiarlas a documentación o repositorio.
- Ejecutar `npm run verify:frontend` antes y después.
- Levantar Supabase local, aplicar migraciones y ejecutar `npm run verify:database`.

20.2 Datos y seguridad

- Migrar esquemas `app`, `security` y `api` sin exponer `app` en Data API.
- Confirmar RLS activo en todas las tablas.
- Confirmar revocación de DML directo para `authenticated`.
- Revisar funciones `SECURITY DEFINER`, `search_path` y grants.
- Ejecutar suites negativas cross-tenant y Platform Admin privacy.
- No migrar datos reales a un entorno de prueba sin anonimización.

20.3 Producto y diseño

- Comparar rutas y menús contra este documento.
- Copiar `globals.css` y catálogo `/design-system`.
- Verificar fuentes, tokens, iconos y Radix UI.
- Revisar tablas, modales, badges interactivos y responsive por rol.
- Mantener banner de modo demostración mientras se usen datos ficticios.

20.4 Integraciones futuras

- Email transaccional: invitaciones y recuperación, con expiración y revocación.
- Storage: archivos privados y URLs firmadas.
- Calendario: OAuth de mínimo alcance y operación degradada.

- Pagos: webhooks firmados, idempotencia y conciliación.
- IA: proveedor, región, retención, evaluación, costos y auditoría.

21. Preguntas obligatorias antes de una nueva función

1. ¿Qué rol la usa y qué problema concreto resuelve?
2. ¿Es clínica, administrativa, comercial o de plataforma?
3. ¿Qué datos necesita y cuál es la fuente de verdad?
4. ¿Quién puede crear, leer, editar, compartir, aprobar y eliminar?
5. ¿Cómo se impide el cruce entre consultorios, profesionales y pacientes?
6. ¿Qué ocurre vacío, cargando, con error, sin permiso, sin plan y sin conexión?
7. ¿Qué cambio requiere auditoría, confirmación o posibilidad de deshacer?
8. ¿Puede resolverse con reglas antes de usar IA?
9. ¿Cuál es el MVP y qué se deja explícitamente para después?
10. ¿Qué criterios de aceptación y pruebas demuestran que funciona sin romper lo anterior?

22. Referencias internas

- [docs/design-system.md](#): tokens visuales resumidos.
- [docs/ui-principles.md](#): principios por rol.
- [docs/security-model.md](#): matriz RLS y privacidad.
- [docs/backend-architecture.md](#): esquemas y límites.
- [docs/data-model.md](#): relaciones e invariantes.
- [docs/api-contract.md](#): vistas y RPC públicas.
- [docs/product-backlog.md](#): priorización.
- [docs/Informe_competitivo_NutriSoft_2026-08-12.docx](#): investigación competitiva.
- [/design-system](#): catálogo interactivo disponible sólo en desarrollo.

23. Historial de decisiones

Fecha	Decisión	Motivo
2026-08-04	Separar persistencia, seguridad y API en tres esquemas.	Privilegio mínimo y contrato controlado.
2026-08-04/05	Endurecer integridad, RLS, RPC, auditoría y pruebas negativas.	Evitar acceso transversal y mutaciones inseguras.
2026-08	Mantener frontend mock hasta cerrar foundation backend.	Preservar estabilidad visual y no integrar auth prematuramente.
2026-08	El Platform Admin sólo ve métricas agregadas y operación comercial.	Privacidad clínica por diseño.
2026-08	Reemplazar selects de estado por badges interactivos en español.	Mejor jerarquía, comprensión y actualización inmediata.
2026-08	Rediseñar el gráfico sin ejes Y y con filtros/tooltip dinámicos.	Claridad visual y lectura exacta por mes.
2026-08	Perfiles de nutricionistas en tarjetas, no fichas horizontales.	Mejor exploración y consistencia con el resto del producto.
2026-08	Empezar HITO Nutricionista antes de ampliar Paciente.	Validar primero el flujo profesional que genera contenido y acciones.
2026-08	Recursos y recetas son propiedad del profesional y se aíslan por asignación.	Privacidad multi-tenant y control de autoría.
2026-08	IA contextual, auditable y con aprobación humana.	Ahorrar tiempo sin delegar criterio clínico.
2026-08-13	Crear este documento maestro y AGENTS.md .	Conservar contexto entre sesiones, migraciones y colaboradores.
2026-08-14	Cerrar la Fase 2.2 con ciclo de alertas, trazabilidad de recomendaciones y publicación controlada de recursos/recetas.	Llegar a autenticación e integración real con contratos funcionales estables y verificables.

CRITERIO DE CIERRE

si un cambio se ve mejor pero debilita claridad, accesibilidad, privacidad, consistencia o estabilidad, no es una mejora para NutriSoft.

